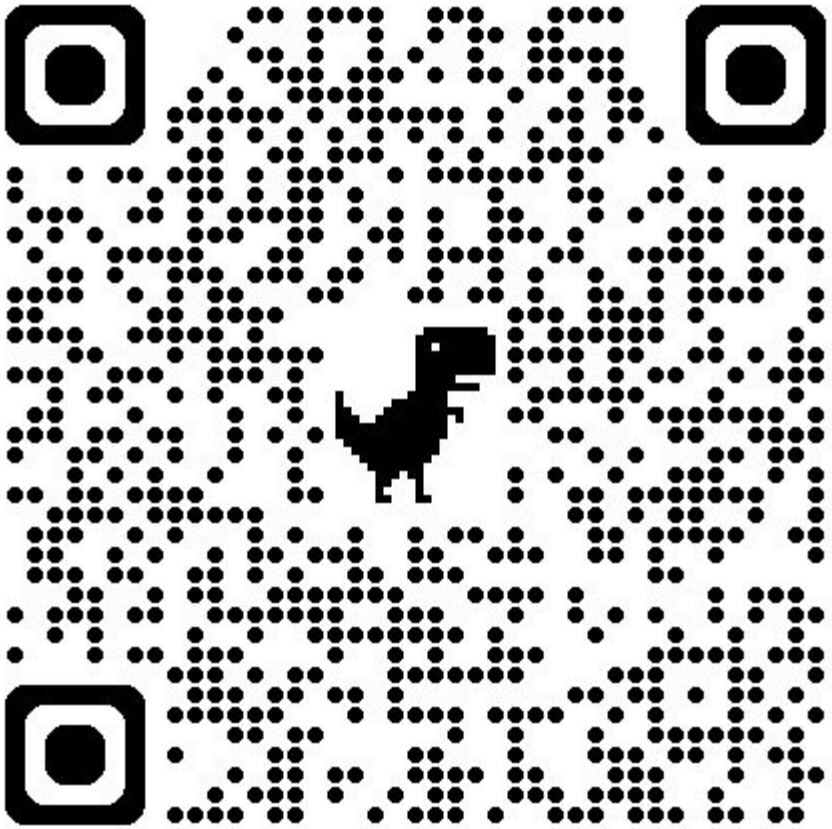
PROTOCOLO HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL

Sharon Katherine Acuña - Ginecóloga y Obstetra/Líder
Ana Sofía Pineda Pinto - Interna ginecología
Sheyla Viveros Pérez - Interna ginecología

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!



PROTOCOLO CLÍNICO PARA

HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL

Revisión de la literatura y propuesta de Abordaje Integral

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

DEFINICIONES

La hemorragia uterina anormal se define como cualquier sangrado de origen uterino con alteración el **volumen**, **duración**, **frecuencia** o **regularidad**, en ausencia de embarazo. Representa un **síntoma clínico** y no un diagnóstico en sí mismo.

Parámetro	Normal	Anormal
Frecuencia	24-38 días	Ausente: amenorrea Infrecuente: >38 días Frecuente: <24 días
Duración	4.5-8 días	Prolongado: >8 días Corto: <4.5 días
Regularidad	Regular: entre ciclo más corto y más largo, variación ≤ 9 días	Irregular: variación entre ciclos ≥10 días
Volumen	5-80 ml	Abundante: >80 ml
Sangrado intermenstrual	Ausente	Presente

Int J Gynecol Obstet 2018; 143: 393–408

EPIDEMIOLOGÍA

- Condición ginecológica frecuente en mujeres en edad reproductiva.
- Prevalencia global: 36–38%; varía según el método de medición.
- A nivel internacional: afecta al 10–30% de las mujeres en edad fértil.
- Forma aguda: prevalencia entre 4–52%.
- En Colombia, la OMS estima una prevalencia del 27%.
- Impacta significativamente la calidad de vida y se asocia a anemia, fatiga y trastornos emocionales.
- Persiste subdiagnóstico y ausencia de guías nacionales para su manejo.

CLASIFICACIÓN

Aguda

Sangrado excesivo, profuso, que empapa una toalla sanitaria o un tampón cada 1-2h y continúa por ≥2h; suficiente para requerir intervenciones urgentes.

Crónica

Sangrado ≥ 6 meses.

ETIOLOGÍA

Adolescentes	19-39 años	Peri - menopáusicas
● Inmadurez del eje H-H-O. ● Coagulopatías.	● Estructurales: PALM ● No estructurales: COEIN	● Atrofia endometrial. ● Ca endometrial.

Pólipos

Son crecimientos hiperplásicos localizados de glándulas endometriales y estroma alrededor de un núcleo vascular que forma una proyección a menudo desde el fondo uterino y se extiende hacia el orificio interno.

- Es una de las causas estructurales más frecuentes de HUA.
- Prevalencia entre 7,8% y 35%.
- Incidencia que aumenta con la edad.
- 95% son benignos.
- Su causa es desconocida pero implica factores genéticos, bioquímicos y hormonales.

Adenomatosos

Quísticos

Fibrosos

Factores de riesgo: edad, el uso de tamoxifeno, el aumento de los niveles de estrógeno endógeno o exógeno, la obesidad y el síndrome de Lynch.

Adenomiosis

Es una condición caracterizada por la presencia de glándulas y estroma endometrial dentro del espesor del miometrio, lo que genera una respuesta hipertrófica e hiperplásica del músculo uterino circundante.

- Prevalencia del 5-70% según los criterios diagnósticos usados.
- La mayoría de casos ocurren en mujeres multíparas en la cuarta a quinta década de la vida.

Focal

Difusa

Quística

Adenomiosis intrínseca

Adenomiosis extrínseca

Leiomiomas

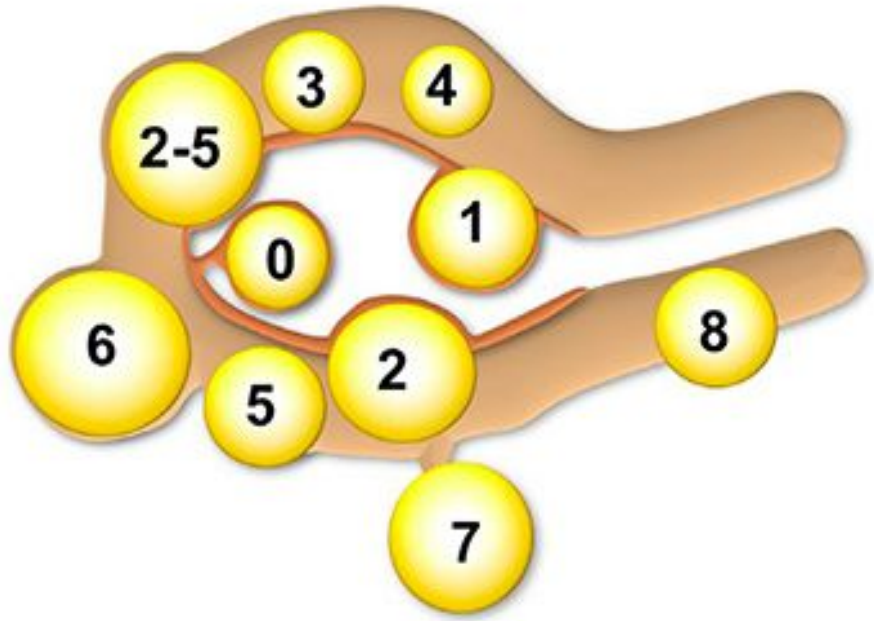
Los leiomiomas, también conocidos como miomas o fibromas, son tumores monoclonales benignos que se desarrollan a partir de las células del músculo liso del miometrio uterino.

- Son los tumores pélvicos más comunes.
- Prevalencia a lo largo de la vida del 70% en mujeres blancas y más del 80% en mujeres negras.
- Prevalencia aumenta con la edad.

Factores de riesgo: raza afroamericana, menarquia temprana, uso temprano de anticonceptivos orales, baja paridad, obesidad, dieta, hipertensión y antecedentes familiares.

Leiomiomas

FIGO leiomyoma subclassification system



SM – submucous	0	Pedunculated intracavitary
	1	<50% intramural
	2	≥50% intramural
	3	Contacts endometrium; 100% intramural
O – Other	4	Intramural
	5	Subserous ≥50% intramural
	6	Subserous <50% intramural
	7	Subserous pedunculated
	8	Other (specify eg, cervical, parasitic)

Hybrid (contact both the endometrium and the serosal layer)	Two numbers are listed separated by a hyphen. By convention, the first refers to the relationship with the endometrium while the second refers to the relationship to the serosa. One example is below.	
	2-5	Submucous and subserous, each with less than half the diameter in the endometrial and peritoneal cavities, respectively.

Int J Gynecol Obstet 2018; 143: 393–408

Malignidad

En mujeres mayores premenopáusicas y menopáusicas, la HUA puede ser secundario a neoplasia intraepitelial endometrial (EIN), que puede ser del subtipo hiperplasia simple o benigna, o del subtipo más preocupante, hiperplasia atípica con progresión a o concurrente con malignidad endometrial.

- Riesgo de por vida del 2.8% para desarrollar Ca de endometrio.
- El 70% de los casos se detectan en etapas tempranas.
- La mayoría de casos (75-90%) presenta HUA.
- Adenocarcinoma endometrioide es el tipo más común.

Factores de riesgo: administración de estrógenos sin oposición en mujeres con útero intacto, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, nuliparidad, uso de tamoxifeno, síndrome de ovario poliquístico, historia de infertilidad, menopausia tardía, enfermedad tiroidea, tumores productores de estrógenos y anovulación crónica.

Coagulopatía

¿Cuándo pensar en ella?

- Menstruaciones abundantes y prolongadas en edad reproductiva temprana.
- Antecedente de hematomas frecuentes, epistaxis, sangrado de encías o dentales, HPP y sangrado quirúrgico grave.
- Antecedente familiar.

Enfermedad de Von Willebrand

Trastornos plaquetarios

Disfunción ovulatoria

La disfunción ovulatoria incluye la ovulación irregular o ausente, lo cual causa un sangrado uterino irregular o amenorrea.

- Es más frecuente en adolescentes y mujeres perimenopáusicas.
- La anovulación produce un endometrio proliferativo persistente por falta de progesterona lútea, asociado a hemostasia endometrial deficiente.
- Puede presentarse evento lúteo fuera de fase: ovulación con altos niveles de estradiol y sangrado abundante.

SOP

Obesidad

Hipotiroidismo

Hiperprolactinemia

Anorexia

Ejercicio extremo

Trastornos del endometrio

Trastornos de la Hemostasia Endometrial

- Ocurren en ciclos ovulatorios regulares con sangrado menstrual abundante.
- Se asocian a alteraciones en la vasoconstricción, inflamación o infección.
- Posibles causas:
    i. Deficiencia de vasoconstrictores (endotelina-1, prostaglandina F2α).
    ii. Exceso de plasminógeno, con lisis acelerada del coágulo.
    iii. Inflamación o endometritis, a menudo por Chlamydia trachomatis o Ureaplasma.
- La etiología exacta aún no está completamente definida.

Iatrogenia

Se relaciona principalmente con el uso de terapias hormonales, fármacos que afectan el eje endocrino o medicamentos que alteran la coagulación.

Hormonales

- ACOS.
- Inyectables.
- Implantes subdérmicos.
- DIU.

Afectan el eje

- Antidepresivos tricíclicos.

Alteran coagulación

- Warfarina.
- Heparinas.
- DOAC.

No clasificada

Este grupo de entidades que causan sangrado uterino anormal está mal definido, no se ha estudiado adecuadamente y, por lo general, es poco frecuente.

- **Hipertrofia miometrial**
- **Istmocele uterino**
- **Malformaciones arteriovenosas**

ABORDAJE DIAGNÓSTICO

HISTORIA CLÍNICA

1. ¿La paciente se encuentra hemodinámicamente estable?
2. ¿Tiene anemia?, ¿Qué grado?
3. ¿Está en embarazo?
4. ¿Cuál es el diagnóstico más probable según su edad?

-Frecuencia
-Regularidad
-Duración
-Volumen
-Cronología del episodio actual
-Episodios similares anteriores

Cuestionario **SAMANTA** como instrumento de cribado validado para la identificación de HUA en mujeres adultas.

Puntuación >=a 3 se considera indicativa de HUA clínicamente relevante que afecta la calidad de vida de la paciente

Cuestionario SAMANTA	Puntuación	
	Sí	No
1. ¿Sangra durante más de 7 días al mes?	3	0
2. ¿Tiene 3 o más días de sangrado más abundante durante su menstruación?	1	0
3. En general, ¿su regla le resulta especialmente molesta debido a su abundancia?	3	0
4. ¿En alguno de los días de sangrado más abundante mancha la ropa por las noches; o la mancharía si no usase doble protección o se cambiase durante la noche?	1	0
5. ¿Durante los días de sangrado más abundante le preocupa manchar el asiento de su silla, sofá, etc.?	1	0
6. En general, ¿en los días de sangrado más abundante, evita (en la medida de lo posible) algunas actividades, viajes o planes de ocio porque debe cambiarse frecuentemente el tampón o la compresa?	1	0

Puntuación total: Un valor ≥ 3 indica que la mujer puede tener sangrado menstrual abundante

Tomado de: J. Perelló, J. Rius Tarruella and J. Calaf, Sangrado menstrual abundante y su detección en la práctica clínica, Med Clin (Barc)., https://doi.org/10.1016/j.medcli.2021.02.006

Cribado inicial para trastornos de la hemostasia

Sangrado menstrual abundante desde la menarquia

Una de las siguientes condiciones

- Hemorragia posparto
- Sangrado relacionado con cirugía
- Sangrado ocasionado por procedimientos dentales

Dos o más de las siguientes

- Moretones una o dos veces al mes
- Epistaxis, una o dos veces al mes
- Sangrado frecuente de encías
- Antecedentes familiares de síntomas de sangrado.

→ En personas que presentan signos o antecedentes que sugieren una alteración en la coagulación.

↓

Posible trastorno de la hemostasia y realizar una evaluación diagnóstica inicial para prevenir complicaciones y orientar un manejo adecuado.

Cribado para trastornos de la hemostasia.Adaptado de: ACOG, Management of acute abnormal uterine bleeding in nonpregnant reproductive-aged woman. Obstet Gynecol 2013; 557:1-6

Descartar diagnósticos diferenciales

Vulva

Crecimientos benignos
Enfermedades ampollosas
Malignidad

Anexos

Malignidad
Enfermedad inflamatoria pélvica

Vagina

- Atrofia
- Crecimientos benignos
- Infección
- Malignidad
- Cuerpo extraño retenido
- Trauma
- Condiciones ulcerativas

Uretra

- Divertículo uretral
- Prolapso uretral
- Uretritis

Ano

- Fisura anal, Hemorroides
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Sangrado gastrointestinal alto o bajo

Otros

Enfermedad renal crónica, Enfermedad hepática crónica
Diabetes mellitus, Leucemia
Sarcoidosis del tracto reproductivo
Tuberculosis del tracto reproductivo
Síndrome de Turner

Embarazo

- Aborto
- Desprendimiento
- Embarazo ectópico
- Enfermedad trofoblástica gestacional
- Hematoma subcorionico

Diagnósticos diferenciales de HUA. Adaptado de: Wouk. N., Helton. M. 2019. Abnormal Uterine Bleeding in Premenopausal Women. American Academy of Family Physicians 99(7): 435 – 443

Ayudas diagnósticas

LABORATORIOS

Estudios iniciales ** tomar a todas**	• Hemograma completo • Prueba de embarazo en mujeres en edad fértil • Tiempos de coagulación (descartar desorden de hemostasia)
Según sospecha por cribado o estudios iniciales	• Fibrinógeno • Antígeno factor Von Willebrand • Factor VII
Otros	• Función hepática, TSH.
Estudio de anemia	• Ferritina, hierro sérico, saturación de transferrina
Origen incierto de sangrado	• Uroanálisis • Sangre oculta en heces

Laboratorios para la evaluación de pacientes con HUA. Adaptado de ACOG, Management of acute abnormal uterine bleeding in nonpregnant reproductive-aged woman. Obstet Gynecol, 2013, vol. 557, 1-6

Ayudas diagnósticas

IMÁGENES

Pólipo • **Ecografia TV:** sensibilidad del 91%, especificidad del 90%; es el método de elección para la evaluación inicial por su accesibilidad y bajo costo. • **Sonohisterografía**: sensibilidad del 95%, especificidad del 92%. • **Histeroscopia** (Gold Standard): sensibilidad del 90%, especificidad del 93%. Permite diagnóstico, toma de biopsia, conocer localización y morfología y, si es posible, realizar polipectomía	**Adenomiosis** • Ecografia TV-Doppler color: Mala definición de la interfase endometrio–miometrio (sensibilidad: 89%, especificidad: 89%) • RNM: no es de elección. sensibilidad: 86%, especificidad: 86%	**Leiomioma** • Ecografía TV • Histeroscopia: gold Standard para evaluar localización, número, tamaño, vascularización y grado de compromiso intramural. Selección de estrategia terapéutica adecuada • RNM: relación de miomas con endometrio y peritoneo.	**Malignidad** • Biopsia endometrial según criterios descritos (de acuerdo a edad y factores de riesgo)
Coagulopatía. • Cribado, hemograma, tiempos de coagulación • antígeno von Willebrand plasmático, actividad von Willebrand plasmática (actividad del cofactor de ristocetina, vWF:RCo y unión al colágeno vWF), factor VIII y otras pruebas de factores.	**Disfunción ovulatoria** • Función tiroidea • B HCG, FSH, LH, prolactina • Descartar toda etiología hormonal	**Trastorno del endometrio** • Descartar infección con FFV / cultivos si requiere • Ecografia TV	**Iatrogenia**: HC **No clasificado** • Exclusión con Ecografía TV / RNM

Métodos diagnósticos recomendados según etiología PALM-COEIN. Fuente: adaptado de (2-4, 10-12)

Biopsia de endometrios:

>= 45 años: a todas las pacientes con HUA

<45 años: HUA +FR Ca de endometrio:

- ○IMC >30
- ○Disfunción ovulatoria crónica
- ○Exposición a estrógenos sin oposición (obesidad, síndrome de ovario poliquístico [SOP])
- ○Uso de tamoxifeno
- ○Falla de tratamiento médico para HUA o HUA persistente
- ○Síndrome de Lynch

ABORDAJE TERAPÉUTICO

Estabilizar a la paciente, controlar la hemorragia y prevenir la recurrencia

TRATAMIENTO NO HORMONAL ⟶ HUA aguda y en casos de HUA crónica donde sea necesario

1.Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) Inhibición la ciclooxigenasa (COX-1 y COX-2): dism. síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. *40%*

- Ibuprofeno 400 mg cada 8 h
- Ácido mefenámico 500 mg/día
- Naproxeno 500 mg cada 12 h

Administración antes del inicio del sangrado



2.Antifibrinolítico Inhibe la activación del plasminógeno, disminuyendo la fibrinólisis.

El régimen más común es de 1 g a 1,3 g cada 6–8 h durante la menstruación



3.Sales de hierro: Indicadas para reponer el hierro perdido en hemorragias agudas o crónicas, cuando no está indicada la transfusión

ABORDAJE TERAPÉUTICO

Estabilizar a la paciente, controlar la hemorragia y prevenir la recurrencia

TRATAMIENTO HORMONAL → Estabilidad hemodinámica y tiempo de evolución

Paciente inestable
(HUA aguda)

1. Evaluar y asegurar vía aérea garantizando Saturación de oxígeno > 92%
2. Canalizar 2 vías con catéter 16
3. Reanimación hídrica con cristaloides - bolos de 500 cc y repetir según requerimiento, al lograr metas mantener 1-2 ml/kg/h
4. Evaluación de respuesta cada 5 minutos con meta PAM > 65, PAS > 90, GU >0.5ml/kg/h, Hemoglobina >7 g/dl en población general o > 8 g/dl en coronariopatías.

MEDICAMENTO	POSOLOGÍA	EFICACIA
Anticonceptivos orales combinados	Monofásico con 30-35 mcg etinilestradiol cada 8 horas por 7 días, luego 1 día por 3 semanas. n	88%
Progestágenos orales	Acetato de medroxiprogesterona 20 mg o acetato de noretisterona cada 8 horas por 7 días, luego 1 dia por 3 semanas	76%

Tratamiento hormonal para HUA aguda. Adaptado de Molina. R., Pérez. M. 2022. Consenso en ginecología: Sangrado uterino anormal. Federación Argentina de sociedades de ginecología y obstetricia

ABORDAJE TERAPÉUTICO

GRADO DE ANEMIA	MANEJO	POSOLOGÍA
Severa (Hb ≤ 7 g/dL)	Transfusión de hemoderivados → hasta lograr un HTO mayor a 30 %.	
	Dosis alta de estrógenos (Terapia opcional) Anticonceptivos con 30 mcg de Etinilestradiol y levonorgestrel 3 mg (o cualquier otro con 30 mcg)	4 mg cada 6 horas hasta que cese el sangrado, seguido de 2 mg cada 6 horas durante 2 días, luego cada 8 horas por 2 días, luego se disminuye cada 12 horas por 2 días más hasta continuar una dosis al día. Se debe agregar un progestágeno durante 10-14 días para estabilizar al endometrio estimulado.
	Acetato de noretisterona	5 - 10 mg VO cada 6 horas durante 4 días, luego cada 8 horas durante 3 días y luego cada 12 horas durante 2 semanas, para terminar única dosis diaria ó; 10-20 mg VO cada 6 - 8 horas durante una semana seguido de 10 -20 mg cada 12 h por una semana y luego única dosis diaria.
	Acetato de medroxiprogesterona	10 mg cada 4 hs vía oral (máx 80 mg) hasta el cese del sangrado, luego cada 6 h por 4 días, luego cada 8 hs por 3 días, luego cada 12 hs por 2 días hasta por dos semanas. Luego uno por día
Moderado (Hb 10 - 8 mg/dL)	Anticonceptivos orales combinados	Monofásico 30-35 mcg de etinilestradiol cada 6 horas durante 2 días, seguido de una pastilla cada 8 horas durante 48 horas. Luego continuar una pastilla cada 12 horas durante 2 días más y se continúa con una pastilla al día. Si el sangrado se reanuda a medida que se reduce la dosis, se pueden tomar 2 veces al día hasta completar 21 días.
Leve (Hb 12 – 10 mg/dL)	Anticonceptivos orales combinados	Monofásico con 30-35 mcg etinilestradiol cada 8 horas por 7 días, luego 1 día por 3 semanas

Hemorragia aguda en pacientes con coagulopatía: desmopresina IV lenta, con una dosis de 0,3 mcg/kg de peso corporal, diluida en 50-100 mL de solución salina fisiológica, administrada durante 15-30 minutos. Si la respuesta es favorable, la dosis puede repetirse 1 o 2 veces más, con intervalos de 6 a 12 horas entre cada administración

Enfoque de tratamiento hormonal en la paciente con HUA aguda, de acuerdo a nivel de hemoglobina. Adaptado de Molina. R., Pérez. M. 2022. Consenso en ginecología: Sangrado uterino anormal. Federación Argentina de sociedades de ginecología y obstetricia

ABORDAJE TERAPÉUTICO

Estabilizar a la paciente, controlar la hemorragia y prevenir la recurrencia

TRATAMIENTO HORMONAL → Estabilidad hemodinámica y tiempo de evolución

Paciente estable (HUA crónica)

OPCIÓN TERAPÉUTICA	CARACTERÍSTICAS	FÁRMACO/DOSIS	EFICACIA
DIU-LNG Primera línea*	La administración de levonorgestrel da como resultado niveles elevados de este en el tejido endometrial, pero con bajos niveles en la circulación sistémica. Conduce al adelgazamiento del endometrio y atrofia glandular, con una reducción del SMA en más de un 80% en un periodo de 3 a 6 meses.	DIU-LNG 52 mg Inserción cada 5 años, con liberación 20 mcg/día El DIU-LNG es el tratamiento de primera línea para el SMA en mujeres sin patología evidente, con miomas menores a 3 cm y sin distorsión de la cavidad uterina o con sospecha o diagnóstico de adenomiosis	**70%** en primeros 3 meses y **96%** al año
ACOS Segunda línea*	Estrógeno: inhibe la FSH, desarrollo folicular, y estabiliza el endometrio. Progestágeno: inhibe LH y la ovulación, crea endometrio atrófico, reduce sangrado. Contraindicaciones: Antecedente o cáncer de mama activo, antecedente de trombosis venosa/arterial o trombosis activa, disfunción hepática, hipertensión no controlada, enfermedad cardiaca valvular complicada, fumadoras > 35 años, migraña con aura, cirugía mayor o inmovilización	Etinilestradiol 30-35 mcg/día se puede utilizar en forma cíclica, rango extendido o continuo - Cíclico: 21 días en tratamiento y 7 días libre → sangrado por deprivación, esquema clásico - Extendido: Ingesta de píldoras por 3 meses aproximadamente, y descanso de 7 dias → RAM spotting - Continuo: en sangrado activo abundante, no hay interrupción de manejo Parche transdérmico, anillo Vaginal	Uso por 6 meses: hasta un **77%**
Progesterona oral Tercera línea*	Promueven la atrofia endometrial y tienen acción antiinflamatoria endometrial. Aunque pueden estar indicados para la mayoría de las mujeres, su uso es particularmente relevante para aquellas con contraindicación a los estrógenos o quienes no los toleran.	Noretisterona (NETA): 5 mg 1–3 veces/día; más potente en supresión endometrial. Medroxiprogesterona (AMP): 5-30 mg/día. Con disfunción ovulatoria durante 10 días al mes. (Fase lútea). Sin disfunción ovulatoria: 1 comp/ día del día 5 al 26 del ciclo o uso continuo Desogestrel diario 150 mcg/día, progestágeno de 3ª generación.	**87%**
Análogo de GnRH	Desensibilización del receptor GnRH → hipogonadismo hipogonadotrófico. Atrofia endometrial en 3–4 semanas. . **Indicaciones:** Preoperatorio en miomatosis: reduce volumen, sangrado y anemia. Cuando otros tratamientos están contraindicados. **Efectos Secundarios:** sofocos, atrofia vaginal, Pérdida de densidad ósea de hasta 6% en 12 meses (recuperable parcial). Considerar antes de cirugía si miomas grandes o útero distorsionado.	Acetato de leuprolide 3.75 mg mensual o 11.25mg trimestral IM Terapias combinadas: Agonistas + estrógenos (solo si síntomas o para evitar pérdida ósea). Agonistas + ACOs: reducen sangrado, aumentan hematocrito con pocos efectos secundarios.	**90%**

Tratamiento hormonal en la paciente con HUA crónica. Adaptado de Molina. R., Pérez. M. 2022. Consenso en ginecología: Sangrado uterino anormal. Federación Argentina de sociedades de ginecología y obstetricia

ABORDAJE TERAPÉUTICO

Estabilizar a la paciente, controlar la hemorragia y prevenir la recurrencia

Otras opciones de manejo farmacológico oral:

➔ Danazol: Andrógeno sintético con efectos biológicos androgénicos débiles. Inhibe la secreción de FSH y LH, por lo que inhibe el desarrollo folicular y produce atrofia endometrial, tiene efectividad de 80% pero por sus RAM no se recomienda RAM: sofocos, mialgias, ganancia de peso y acné

➔ Acetato de medroxiprogesterona de depósito 150 mg cada 12 semanas IM - inyección trimestral → eficacia 48%, no es de elección

➔ Implante subdérmico etonogestrel: no hay suficientes estudios

MEDICAMENTO	DOSIFICACIÓN
Acetato de medroxiprogesterona	10 mg VO, 1-2 comprimidos cada 12 horas por 10 días
Acetato de Noretisterona	10 mg VO cada 24h por 10 días
Progesterona Micronizada	200 mg VO cada 24 horas por 10 días
Drospirenona	4 mg VO cada 24 h por 24 días
Análogos de GnRH	1 mg IV cada 24 h por 3 meses

Contraindicaciones a los estrógenos

Alternativas de tratamiento en pacientes con contraindicación a los estrógenos. Adaptado de Molina. R., Pérez. M. 2022. Consenso en ginecología: Sangrado uterino anormal. Federación Argentina de sociedades de ginecología y obstetricia

ABORDAJE EN LA PERIMENOPAUSIA

- Primera línea: DIU LNG, seguro en riesgo trombótico o pacientes con baja adherencia
- Segunda línea: ACOS
- Si hay contraindicación para ACO, solo gestagenos.

TIPO	DOSIS	CARACTERÍSTICAS
Drospirenona + Etinilestradiol	3 mg/0,03 mg vía oral	La drospirenona tiene acción antiandrogénica; útil para pacientes con síntomas cutáneos o retención de líquidos.
Etinilestradiol + Gestodeno	0,020/0,075 mg vía oral 0,015/0,06 mg vía oral	Disminuyen los niveles de FSH. El gestodeno se absorbe rápido y su biodisponibilidad es del 99%.
Norelgestromina + Etinilestradiol	6 mg/600 mcg parche transdérmico	Anticoncepción efectiva.

TIPO	DOSIS	CARACTERÍSTICAS
DIU-Levonorgestrel (LNG)	52 mg/dispositivo, con liberación de 20 µg/día	1° línea de tratamiento; duración de 7 años; uso en mujeres con contraindicaciones relativas a gestágenos orales o que no desean/pueden efectuar tratamientos diarios.
Acetato de megestrol	20–160 mg/día vía oral	Alternativa eficaz en casos en que no se pueden usar ACO.
Acetato de medroxiprogesterona	10 mg/día vía oral o intramuscular (depot c/3 meses)	Agente clásico con acción endometrial probada.
Acetato de noretisterona	15 mg/día vía oral	Útil combinado con anticonceptivos.
Progesterona natural o micronizada	200–300 mg/día, vía oral o vaginal	Acción poco potente. Se recomienda su uso en mujeres de bajo riesgo.

gestágenos

Anticonceptivos combinados para pacientes en perimenopausia. Adaptado de Molina. R., Pérez. M. 2022. Consenso en ginecología: Sangrado uterino anormal. Federación Argentina de sociedades de ginecología y obstetricia
Gestágenos para pacientes en perimenopausia. Adaptado de Molina. R., Pérez. M. 2022. Consenso en ginecología: Sangrado uterino anormal. Federación Argentina de sociedades de ginecología y obstetricia

Gracias

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

ANA MARITZA DÁVILA BARÓN

GERENTE

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

